

Fecha Última Actualización: 05-07-2022 15:45:18

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Angelo Jonathan Santibañez Cabrera
Edad : 47a 2m 4d
Dirección : 3 Norte 063

Rut : 12.741.642-7
Fecha Nacto: 01/05/1975
Comuna : La Granja

N° Archivo : 1320200
Sexo : Masculino
Teléfono : 2 2526 9845

N° Epicrisis
312911

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 26/06/2022 10:51

Días Estadía : 9

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 05/07/2022 15:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

gran quemado

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UCI
05/07/2022

Ángelo Santibañez Cabrera

Edad: 47 años

RUT: 12741642-7

Fecha ingreso CASR 26/6/22

Fecha ingreso Recu-UCI: 27/06/2022

Fecha ingreso UPC (MODULO C - CAMA 1):27/06/2022 - HORA: 07:30 AM

DIAGNOSTICOS DE INGRESO :

Gran quemado (18%SCT)

Quemaduras A-AB cabeza, region cervical, brazos y manos por anterior+ torax

Quemadura de vía aérea

AKI K DIGO II

Falla respiratoria tipo 1

Antecedentes

Mórbidos: HTA, Retraso mental

Medicamentos: No conocidos

Quirúrgicos: No conocidos

Alergias (-)

Historia

Paciente con antecedentes descritos, ingresa al reanimador de HSR desde Hospital Padre Hurtado por quemadura de gran extensión en contexto de incendio en el hogar alrededor de las 7:15 am del 26/06, siendo rescatado por bomberos. requirió intubación orotraqueal, hemodinámicamente estable, con quemaduras de primer y segundo grado en tórax y hacia cefálico, sedación profunda y conexión a VMI bajo parámetros protectores.

Volemización según Parkland (3,7 litros en las primeras 8 horas y luego completar 7.5 en las próximas 24 horas). De los exámenes de laboratorio de ingreso destaca Lactico 50, LDH 623, CK 327, Crea 1.2, Troponinas 1857. Se decide realización de aseo quirúrgico en pabellón. Se realiza aseo quirúrgico de zonas de quemadura sin incidentes. Ingresa a sala de

Fecha Epicrisis : 05/07/2022 15:45

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 05-07-2022 15:45:18

Página 2 de 2

recuperación, se continúa con reanimación con volumen; recibió en urgencias 5.500 cc de cristaloides, calculados en infusión restante para las próximas 16 horas (353 ml/hr), se mantuvo sedado con fentanyl + midazolam + BIC de rocuronio, apoyado con NA para PAM 75.

Ingresa a UCI a las 07:30 AM del 27/6/2022:

SNC. Ingresa con sedoanalgesiado, RASS -5, midazolam 0.09 mg/kg/h + fentanilo 3 µg/kg/h.

Hemodinamia: ingresa a UPC recibiendo noradrenalina 0.1 µg/kg/min, completó Volemización por Parkland.

Ventilatorio. PaFi de control alrededor de 200, evoluciona con deterioro progresivo de oxigenación, se realizó fibrobroncoscopia de aseo que evidenció quemadura de vía aérea, se repitió aseo bronquial el 04/07/2022 observando mejoría de dicha quemadura.

Renal. Falla renal aguda KDIGO 2.

Inflamatorio/infeccioso: parámetros inflamatorios elevados; Rx de tórax con opacidades para hiliares derechas, podría estar en contexto de aspiración por lo que inició ampicilina sulbactam, evolucionó febril persistente, se cultivó y se escaló a antibiótico de amplio espectro.

Quirúrgico: Dos aseos quirúrgicos, sin interurrencias.

Evolucionó con deterioro progresivo de falla respiratoria a pesar de mejoría de quemadura de vía aérea evidenciada por fibrobroncoscopia, con sospecha de TEP inició anticoagulación el 05/07/2022 en horas de la madrugada; febril persistente con hemocultivos, urocultivos y cultivos de aspirado traqueal pendientes, recibiendo como tratamiento empírico Imipenem.

El 05/07/2022 aproximadamente a las 07:00 H presenta paro cardiorrespiratorio en actividad eléctrica sin pulso; inicia maniobras de reanimación avanzada según ACLS, Ecocopia con dilatación de cavidades derechas, impresiona TEP masivo, recibe trombólisis de urgencia con alteplasa, revierte a circulación espontánea después del ciclo 18, requiere noradrenalina y adrenalina en dosis muy altas (hasta 1.5 µg/kg/min y hasta 1 µg/kg/min respectivamente), suma sangrado digestivo evidenciado por sonda nasogástrica, evoluciona con hipotensión sostenida a pesar de reanimación con volumen y dosis de vasoactivos mencionados; se da aviso a la familia y se permite acompañamiento, fallece a pesar de todas las medidas mencionadas el 05/07/2022 a las 13:48

Diagnóstico de Egreso

QUEMADURA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, PARTE NO ESPECIFICADA -
QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 20 AL 29% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

se envía formulario para remitir al servicio medico legal desde establecimiento de salud

Plan Post Alta

MANEJO MEDICO LEGAL

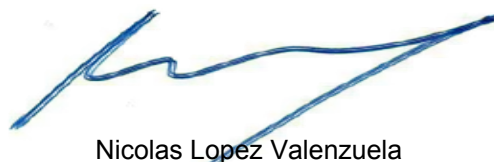
Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



Nicolas Lopez Valenzuela

Becado/Residente



Guillermo Molina Mancero

Médico Tratante (Staff)

INTERNO

Fecha Epicrisis : 05/07/2022 15:45

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:57

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar